

Wszystko *działa*

Kariera, rodzina, finanse — i regularne picie, które jeszcze nie zostawiło widocznych śladów. Najbardziej ukryta i najdłużej nierozpoznawana postać AUD.

CZAS: 15 min Samodiagnostyka i autorefleksja

ŹRÓDŁO: Benton (2009); Moss i wsp. (2007, NESARC); NICE CG115

JAK UŻYWAĆ

Sprawdź **profil HFA** w sekcji 01 — pięć cech, które najczęściej współwystępują u osób z tym wzorcem. W sekcji 02 zobacz, *jakimi liczbami* można to opisać poza intuicją. Sekcja 03 prowadzi przez **rzut w przyszłość** — pytanie, które omija typowy opór „teraz jest OK”. Na końcu krótka decyzja.

DLACZEGO TO DZIAŁA

HFA (ang. *high-functioning alcoholism*, alkoholizm wysokofunkcjonujący) — termin zaproponowany przez Benton (2009) i potwierdzony w analizie Moss i wsp. (2007) na danych NESARC jako jeden z pięciu odrębnych podtypów AUD. Stanowi ~20% osób z AUD. Charakterystyka: **utrzymane funkcjonowanie** (praca, relacje, finanse) + **picie ryzykowne lub szkodliwe** + silny opór poznawczy („skoro funkcjonuję, nie mam problemu”). Konsekwencja kliniczna: **rozpoznanie opóźnia się o 8-10 lat** względem stereotypowych obrazów AUD, a w momencie diagnozy często są już widoczne uszkodzenia narządowe. Wstyd i ukrywanie są wbudowane w wzorec — wczesna autodiagnostyka jest najwartościowszą interwencją.

01 Pięć cech profilu — zaznacz, co Cię opisuje

1 · FUNKCJONOWANIE ZEWNĘTRZNE ☐

Praca, finanse, rodzina są stabilne. Sąsiedzi, koledzy, klienci nie podejrzewają. Często wykształcenie wyższe, odpowiedzialna rola. To *pierwsza linia obrony* przed diagnozą.

2 · WZORZEC „KONTROLOWANY” ☐

Picie tylko **wieczorem** lub **w weekendy**, nigdy „rano”. To poczucie kontroli pozornie zaprzecza problemowi. W rzeczywistości regularność jest sednem AUD, a nie pora dnia.

3 · WYBÓR „LEPSZEGO” ALKOHOLU ☐

„Tylko wino”, „tylko whisky single malt”, „dobry koniak” — wybór jakości jako kolejna linia obrony („jestem koneserem, nie alkoholikiem”). 750 ml wina = 7 drinków, niezależnie od ceny.

4 · IZOLOWANE PICIE ☐

W domu, po pracy, kiedy nikt nie patrzy. Często z *ukrywaniem* — schowane butelki, butelki opisane jako co innego. To zwykle pierwszy sygnał alarmowy dla samej osoby.

5 · WEWNĘTRZNY DYSKOMFORT ☐

Podwójne życie: zewnątrz „wszystko gra”, wewnątrz — lęk przed odkryciem, wstyd, poczucie izolacji, czasem złość na sytuację. Często bezsenność i poranny lęk. To wewnętrzne objawy zwykle są pierwsze, długo zanim pojawiają się skutki zdrowotne.

02 Liczby, które omijają „wydaje mi się”

HFA wygra każdą argumentację „czuję, że jest OK”. Co nie wygra — to konkretne, mierzalne liczby. Cztery pytania, które zostawiają mniej miejsca na minimalizowanie. Odpowiedz na każde liczbą, nie wrażeniem.

ILE DRINKÓW STANDARDOWYCH

— wypilem/-am w typowy tydzień ostatnio

ILE DNI BEZ ALKOHOLU W TYPOWYM TYGODNIU

MÓJ OSTATNI WYNIK GGT

— data badania, jeśli wykonałem/-am

MÓJ WYNIK AUDIT

— jeśli wypełniałem/-am

Punkt odniesienia WHO: picie niskiego ryzyka — mężczyzna ≤ 2 drinki/dzień, kobieta ≤ 1 , minimum 2 dni bez alkoholu w tygodniu. Powyżej — picie ryzykowne, niezależnie od tego, czy „wszystko działa”. Ryzyko narządowe (wątroba, serce, rak) zaczyna rosnać od pierwszego drinka — i nie czeka na pojawienie się konsekwencji życiowych.

03 Rzut w przyszłość — pytanie, które omija opór

HFA wygrywa argument „teraz jest OK”, bo *teraz* faktycznie często jest OK. Bilans zysku i straty **otwiera się dopiero w perspektywie 10 lat**. To pytanie, które wielu klinicystów uważa za jedno z najmocniejszych w pracy z HFA.

„Wyobraź sobie swoje życie **za 10 lat**, jeśli picie będzie się utrzymywać na obecnym poziomie lub nasilać. Co widzisz? Jak wygląda Twoje zdrowie, praca, relacje, sen, energia?”

MOJA ODPOWIEDŹ NA TO PYTANIE

— bez cenzurowania

JEDEN NAJMNIEJSZY KROK, KTÓRY PODEJMĘ W TYM TYGODNIU

Klucz: HFA *nie jest* mniejszą wersją alkoholizmu — jest **tym samym AUD**, tylko z opóźnioną wizytą u lekarza. Benton (2009): średnie opóźnienie diagnozy 8–10 lat względem klasycznego obrazu AUD; w momencie rozpoznania **72%** ma już zmiany w GGT lub MCV. Najsilniejszą interwencją w tym wzorcu nie jest konfrontacja („masz problem”) — jest spokojny rzut w przyszłość i konkretna liczba w teraźniejszości. *Funkcjonowanie nie jest dowodem na brak problemu — jest dowodem na to, jak dużo radzi sobie Twój organizm pomimo problemu.*